สมาคมประกันชีวิตไทย
The Thai Life Assurance Association

COPAYMENT

Copayment = จ่ายร่วม แต่มั่นคงระยะยาว





(กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน เอกสารมีทั้งหมด 7 หน้า)

สมาคมประกันชีวิตไทย
The Thai Life Assurance Association

COPAYMENT



ใครบ้างที่จะเข้าเงื่อนไข Copayment

กรมธรรม์ประกันสุขภาพที่เริ่มคุ้มครอง **ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป**
จะมีเงื่อนไข Copayment ระบุในกรมธรรม์
ซึ่งจะมีเกณฑ์การเข้าเงื่อนไข Copayment ระบุไว้อย่างชัดเจน
ดังนั้น ควรทำความเข้าใจเงื่อนไขของ Copayment อย่างละเอียด

สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2568
เกณฑ์การเข้าเงื่อนไข Copayment แบ่งออกเป็น 3 กรณี

กรณีที่ 1: การเจ็บป่วยเล็กน้อย (Simple diseases)

กรณีที่ 1 — การเคลมสำหรับ **โรคที่ไม่รุนแรง** (Simple Diseases) หรืออาการที่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
จำนวนการเคลม มากกว่าหรือเท่ากับ **3** ครั้ง ต่อปีกรมธรรม์
และ
อัตราการเคลม มากกว่าหรือเท่ากับ **200%** ของเบี้ยประกันสุขภาพ
จะต้องร่วมจ่าย **30%** ทุกค่ารักษาในปีถัดไป

กรณีที่ 2: การเจ็บป่วยโรคทั่วไป (ไม่รวมโรคร้ายแรงและการผ่าตัดใหญ่)

กรณีที่ 2 — การเคลมสำหรับ **โรคทั่วไป** แต่ไม่นับรวม การผ่าตัดใหญ่ และโรคร้ายแรง
จำนวนการเคลม มากกว่าหรือเท่ากับ **3** ครั้ง ต่อปีกรมธรรม์
และ
อัตราการเคลม มากกว่าหรือเท่ากับ **400%** ของเบี้ยประกันสุขภาพ
จะต้องร่วมจ่าย **30%** ทุกค่ารักษาในปีถัดไป

กรณีที่ 3: หากเข้าเงื่อนไขทั้งในกรณีที่ 1 และ 2

กรณีที่ 3 — **การเคลมเข้าเงื่อนไข** กรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2
จะต้องร่วมจ่าย **50%** ทุกค่ารักษาในปีถัดไป

ถ้าเข้าเงื่อนไข Copayment แล้วจะมีผลทุกปีกรมธรรม์หรือไม่ หรือแค่ปีกรมธรรม์เดียว

ปีกรมธรรม์ 2568
เข้าเงื่อนไข กรณีที่ 1, กรณีที่ 2, กรณีที่ 3

ปีกรมธรรม์ 2569
ต้องร่วมจ่าย Copayment **30%** หรือ **50%**

ปีกรมธรรม์ 2570
จะเข้าเงื่อนไข Copayment หรือไม่ ขึ้นอยู่กับอัตราการเคลมในปี 2569 เข้าเงื่อนไขกรณีที่ 1, 2 หรือ 3

สรุป : Copayment จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อสถานการณ์การเคลมดีขึ้น โดยบริษัทจะพิจารณาทุกรอบปีกรมธรรม์

(กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน เอกสารมีทั้งหมด 7 หน้า)

สมาคมประกันชีวิตไทย
The Thai Life Assurance Association

เกณฑ์การเข้าเงื่อนไข COPAYMENT

สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2568

1 กรณีการเจ็บป่วยเล็กน้อย Simple diseases



การเคลมสำหรับโรคที่ไม่รุนแรง (Simple diseases)
หรืออาการที่ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล
จำนวนการเคลม >= 3 ครั้งต่อปีกรมธรรม์
และมีอัตราการเคลม >= 200% ของเบี้ยประกันสุขภาพ
จะต้องร่วมจ่าย **30%** ทุกค่ารักษาในปีกรมธรรม์ถัดไป

ตัวอย่าง การเจ็บป่วยเล็กน้อย (Simple diseases)
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพต่อปี 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการเจ็บป่วยเล็กน้อย
ครั้งที่ 1 : 10,000 บาท **ครั้งที่ 2 :** 15,000 บาท **ครั้งที่ 3:** 20,000 บาท
การคำนวณอัตราการเคลม : $\frac{10,000+15,000+20,000}{20,000}$ x 100 = 225%
ผลลัพธ์ เนื่องจากมีการรักษา >= 3 ครั้ง และอัตราการเคลม >= 200%
ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่าย Copayment **30%**
สำหรับค่ารักษาในปีกรมธรรม์ถัดไป

2 กรณีการเจ็บป่วยโรคทั่วไป (ไม่รวมโรคร้ายแรง และการผ่าตัดใหญ่)



สำหรับการเคลมโรคทั่วไป แต่ไม่นับรวมการผ่าตัดใหญ่ และโรคร้ายแรง
จำนวนการเคลม >= 3 ครั้งต่อปีกรมธรรม์
และมีอัตราการเคลม >= 400%
ของเบี้ยประกันสุขภาพ จะต้องร่วมจ่าย **30%**
ทุกค่ารักษาในปีกรมธรรม์ถัดไป

ตัวอย่าง การเจ็บป่วยทั่วไป (ไม่นับรวมโรคร้ายแรง และการผ่าตัดใหญ่)
ค่าเบี้ยประกันสุขภาพต่อปี 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยใน (IPD) สำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป
ครั้งที่ 1 : 30,000 บาท **ครั้งที่ 2 :** 25,000 บาท **ครั้งที่ 3:** 30,000 บาท
การคำนวณอัตราการเคลม : $\frac{30,000+25,000+30,000}{20,000}$ x 100 = 425%
ผลลัพธ์ เนื่องจากมีค่ารักษา >= 3 ครั้ง และอัตราการเคลม >= 400%
ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่าย Copayment **30%**
สำหรับค่ารักษาในปีกรมธรรม์ถัดไป

3 เข้าเงื่อนไข ทั้งในกรณีที่ 1 และ 2



การเคลมเข้าเงื่อนไข **กรณีที่ 1** การเจ็บป่วยเล็กน้อย
(Simple Diseases) และ**กรณีที่ 2** การเจ็บป่วยทั่วไป
จะต้องร่วมจ่าย **50%**
ทุกค่ารักษาในปีกรมธรรม์ถัดไป

ตัวอย่าง สำหรับการเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือการเจ็บป่วยทั่วไป
(ไม่นับรวมโรคร้ายแรง และผ่าตัดใหญ่)

ครั้งที่ 1 : 10,000 บาท	**ครั้งที่ 1** : 30,000 บาท
ครั้งที่ 2 : 15,000 บาท	**ครั้งที่ 2** : 25,000 บาท
ครั้งที่ 3 : 20,000 บาท	**ครั้งที่ 3** : 30,000 บาท

การคำนวณอัตราการเคลมสำหรับการเจ็บป่วยเล็กน้อย
$\frac{(10,000+15,000+20,000)}{20,000}$ x 100 = 225%
การคำนวณอัตราการเคลมสำหรับการเจ็บป่วยทั่วไป
$\frac{30,000+25,000+30,000}{20,000}$ x 100 = 425%
ผลลัพธ์ เนื่องจากเข้าเงื่อนไขทั้งกรณีที่ 1 และ 2
ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่าย Copayment **50%**
สำหรับค่ารักษาในปีกรมธรรม์ถัดไป

การคำนวณอัตราการเคลม

$$\frac{\text{ค่ารักษาพยาบาล ที่บริษัทประกันภัยจ่ายต่อปีกรมธรรม์}}{\text{ค่าเบี้ยประกันสุขภาพต่อปีกรมธรรม์}} \times 100 = \% \text{ อัตราการเคลม}$$

(กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน เอกสารมีทั้งหมด 7 หน้า)



ถ้าเข้าเงื่อนไข Copayment ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2568 จะต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในทุกๆ การรักษาหรือไม่

สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไข Copayment
ในปีต่ออายุถัดไป ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายสัดส่วนที่กำหนด **30%** หรือ **50%**
ทุกค่ารักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายแรง หรือการผ่าตัดใหญ่

ตัวอย่าง สถานการณ์ปีกรมธรรม์ที่เข้าเงื่อนไข สำหรับ Copayment 30%

ผู้เอาประกันภัยเข้าโรงพยาบาล 3 ครั้ง	ค่ารักษาพยาบาล	ผู้เอาประกันภัยจ่าย 30%
ครั้งที่ 1 โรคร้ายแรง (Critical illness)	**200,000 บาท**	**60,000 บาท**
ครั้งที่ 2 การผ่าตัดใหญ่ (Major surgery)	**300,000 บาท**	**90,000 บาท**
ครั้งที่ 3 โรคร้ายแรง (Critical illness)	**200,000 บาท**	**60,000 บาท**
	รวมที่ผู้เอาประกันภัยจ่าย:	**210,000 บาท**



เนื่องจากค่ารักษาทั้งหมดเป็น **โรคร้ายแรง และการผ่าตัดใหญ่**
จึงไม่นับรวมการคำนวณเงื่อนไข Copayment ผู้เอาประกันภัย
จึงไม่ต้องจ่ายร่วม Copayment ในปีถัดไป

ถ้าเข้าเงื่อนไข Copayment แล้ว จะมีผลทุกปีกรมธรรม์หรือไม่ หรือแค่ปีกรมธรรม์เดียว



Copayment จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อสถานการณ์การเคลมดีขึ้น โดยบริษัทประกันภัย
จะพิจารณาทุกรอบปีกรมธรรม์ถ้าปีกรมธรรม์ใดไม่เข้าเงื่อนไข
กรณีใดกรณีหนึ่ง ผู้เอาประกันภัยก็จะไม่มีส่วนร่วมจ่าย Copayment
ในปีกรมธรรม์ถัดไป แต่ถ้าปีกรมธรรม์ใดเข้าเงื่อนไข
ก็จะต้องร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาลในปีกรมธรรม์ถัดไปเช่นกัน



ลูกค้าที่ซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพก่อนหน้านี้ จะเข้าเงื่อนไข Copayment ด้วยหรือไม่

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพที่มีผลคุ้มครอง
ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2568 **และไม่ปล่อยให้ขาดอายุ**
(ต่ออายุอย่างต่อเนื่อง) จะไม่มีเงื่อนไข Copayment

SIMPLE DISEASES คืออะไร



ลักษณะของ Simple Diseases

อาการไม่รุนแรง:
อาการมักไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันในระยะยาว

รักษาง่าย:
การรักษามักไม่ซับซ้อน เช่น การใช้ยาสามัญประจำบ้าน หรือวิธีการธรรมชาติ

หายได้เอง:
ในบางกรณีร่างกายสามารถฟื้นตัวได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการรักษา

พบได้บ่อย:
เป็นโรคหรืออาการที่พบได้ทั่วไปในทุกเพศทุกวัย

ตัวอย่างการเจ็บป่วยเล็กน้อย (Simple Diseases)

- เวียนศีรษะ
- ไข้ไม่ระบุสาเหตุ
- ปวดหัว
- ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
- ไข้หวัดใหญ่
- ภูมิแพ้
- กล้ามเนื้ออักเสบ
- ท้องเสีย
- โรคกระเพาะอาหารอักเสบและกรดไหลย้อน

สมาคมประกันชีวิตไทย
The Thai Life Assurance Association

รายชื่อโรคร้ายแรง และผ่าตัดใหญ่ ที่การเคลมจะไม่ถูกนับเข้าเงื่อนไข Copayment

สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2568

- โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์ (Alzheimer's disease)
- โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease)
- โรคโลหิตจางจากไขกระดูกไม่สร้างเม็ดโลหิต (Aplastic Anemia)
- โรคเยื่อหุ้มสมอง และไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial meningitis)
- เนื้องอกในสมองชนิดที่ไม่ใช่มะเร็ง (Benign brain tumor)
- ตาบอด (Blindness)
- โรคมะเร็งระยะลุกลาม (Invasive Cancer)
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiomyopathy)
- ตับวาย (Chronic Liver Disease/End-stage Liver disease/ Liver failure)
- โรคหลอดลมปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง/โรคปอดระยะสุดท้าย (Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease/ End-stage Lung disease)
- ภาวะโคม่า (Coma)
- โรคหลอดเลือดหัวใจตีบที่รักษาด้วยการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Artery Disease requiring Angioplasty)
- การผ่าตัดเส้นเลือดเลี่ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-pass Surgery)
- กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
- การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
- ไตวายเรื้อรัง(Chronic Kidney Failure)
- การสูญเสียการได้ยิน (Loss of Hearing)
- การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ (Loss of independent living)
- การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (Total and permanent disability – TPD)
- การสูญเสียความสามารถในการพูด (Loss of speech)
- แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major burn)
- การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
- การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation or Bone Marrow Transplantation)
- โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor Neuron Disease)
- โรคระบบประสาทมัลติเพิล สะเคลอโรสิส (Multiple Sclerosis)
- โรคกล้ามเนื้อเสื่อม (Muscular Dystrophy)
- โรคไวรัสตับอักเสบชนิดรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
- โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ (Other serious Coronary Artery Diseases)
- อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา (Paralysis)
- โรคพาร์กินสัน (Parkinson's Disease)
- โรคแรงดันในหลอดเลือดแดงปอดสูงแบบปฐมภูมิ (Primary Pulmonary Arterial Hypertension)
- ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง(Severe Rheumatoid Arthritis)
- โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
- การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
- ไตอักเสบลูปัสจากโรคซิสเต็มมิค ลูปัส อิริเธมา โตซู่ส (Lupus Nephritis from Systemic Lupus Erythematosus)
- สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
- ภาวะอะแพลลิก (Apallic Syndrome หรือ Vegetative State)
- โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ต้องรักษาโดยการผ่าตัด (Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery)
- โรคหลอดเลือดสมองที่ต้องได้รับการผ่าตัดลอกหลอดเลือดแดงคาโรติด (Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery)
- การฉีกขาดของรากประสาทต้นแขน (Multiple root avulsions of Brachial Plexus)
- โรคโปลิโอ (Poliomyelitis)
- การผ่าตัดกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ (Surgery for Idiopathic Scoliosis)
- ภาวะตับอ่อนอักเสบที่กลับเป็นซ้ำและเรื้อรัง (Chronic Relapsing Pancreatitis)
- โรคเท้าช้าง (Elephantiasis)
- โรคถุงน้ำในไต (Medullary Cystic Disease)
- โรคเนื้อเยื่อพังผืดอักเสบติดเชื้อและเป็นเนื้อตาย (Necrotizing Fasciitis and Gangrene)
- โรคหนังแข็งชนิดลุกลาม (Progressive Scleroderma or Diffuse systemic sclerosis/scleroderma)
- โรคลำไส้อักเสบเป็นแผลรุนแรง (Severe Ulcerative Colitis or Crohn's Disease)
- โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม (Non-invasive cancer / Carcinoma in Situ)
- โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองที่รักษาโดยใช้ขดลวดผ่านสายสวนทางหลอดเลือด (Cerebral Aneurysm Treatment by Endovascular Coiling)
- โรคหลอดเลือดสมองที่ได้รับการรักษาโดยวิธีใส่สายสวนเส้นเลือดแดงบริเวณคอ (Stroke Treatment by Carotid Angioplasty and Stent Placement)

ผ่าตัดใหญ่ คือ การผ่าตัดที่ต้องใช้ยาสลบ หรือการบล็อกเฉพาะส่วน เช่น บล็อกหลัง บล็อกแขน บล็อกขา

(กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน เอกสารมีทั้งหมด 7 หน้า)

สมาคมประกันชีวิตไทย
The Thai Life Assurance Association



FAQ รวมคำถามเกี่ยวกับ COPAYMENT

สำหรับกรมธรรม์ใหม่ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2568

ถาม เงื่อนไข Copayment มีผลทั้ง IPD และ OPD ใช่หรือไม่

ตอบ ไม่เกี่ยวกับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก (OPD) ใช้เฉพาะกับการรักษาแบบผู้ป่วยใน (IPD)

ถาม จะทราบได้อย่างไรว่า เราเข้าเงื่อนไข Copayment

ตอบ บริษัทประกันภัยจะมีหนังสือแจ้งล่วงหน้าก่อนครบชำระเบี้ยประกันภัยไม่น้อยกว่า 15 วัน หากเกิดการเคลมภายหลังจากที่บริษัทได้ออกหนังสือแจ้งชำระเบี้ยประกันภัย และเข้าเงื่อนไข Copayment บริษัทจะออกเอกสาร บันทึกสลักหลัง (Endorsement) เพื่อแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงและเงื่อนไขเพิ่มเติมให้ผู้เอาประกันภัยทราบ

ถาม ในกรณีที่การเคลมมีการปรับตัวลดลง และไม่เข้าเงื่อนไขจ่ายร่วม Copayment บริษัทประกันภัยจะพิจารณาในการยกเลิก Copayment หรือไม่ และมีหลักเกณฑ์รอบการพิจารณาอย่างไร

ตอบ บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุกรอบปีกรมธรรม์ หากการเคลมของผู้เอาประกันภัยมีการปรับตัวลดลงตามเกณฑ์บริษัทประกันภัยจะยกเลิกการมีส่วนร่วมจ่าย Copayment

ถาม ถ้าผู้เอาประกันภัยที่เข้าเงื่อนไข Copayment แล้วจะเข้าเงื่อนไขตลอดไป หรือแค่ปีเดียว

ตอบ เงื่อนไข Copayment จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อสถานการณ์การเคลมของแต่ละบุคคล โดยบริษัทจะพิจารณาทุกรอบปีกรมธรรม์

ถาม ถ้าเข้าเงื่อนไข Copayment แล้วเบี้ยประกันภัยจะลดลงหรือไม่

ตอบ กรณีการเข้าเงื่อนไข Copayment เนื่องจากเข้าเกณฑ์ Copayment (จำนวนการรักษาและอัตราการเคลมเกินกำหนด) จะไม่มีการลดเบี้ยประกันภัย

ถาม ถ้าเข้าเงื่อนไข Copayment แล้ว ทุกการจ่ายค่ารักษาพยาบาลจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายหรือไม่ รวมโรคร้ายแรงและการผ่าตัดใหญ่ด้วยหรือไม่

ตอบ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายในทุกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการรักษาโรคร้ายแรง และการผ่าตัดใหญ่

ถาม Copayment กับ Deductible ต่างกันอย่างไร

ตอบ Copayment คือ ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีส่วนร่วมจ่ายตามเปอร์เซ็นต์ของค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามที่ระบุไว้
Deductible คือ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลส่วนแรกตามจำนวนที่ระบุไว้ในแบบประกันภัย

ถาม ถ้ากรมธรรม์มี Deductible และเข้าเงื่อนไข Copayment จะต้องมีส่วนจ่ายอย่างไร

ตอบ ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่าย Deductible ส่วนแรกก่อน แล้วนำสิ่งที่เหลือมาคำนวณ Copayment 30% หรือ 50% แล้วแต่กรณี

(กรุณาศึกษารายละเอียดให้ครบถ้วน เอกสารมีทั้งหมด 7 หน้า)